



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : راقيه محمد فرج حسين
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الشراييه
رقم البطاقة : 26205062100922 رقم التليفون : 01017979920
العنوان : الشركة
العمر (تاريخ الميلاد) : 06-05-1962 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: راقية محمد فرح حسين National ID: 26205062100922	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Doc 3022c

14

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

راقية
محمد فرج حسين
ش ٢٢ عبد المنعم السعدني - أرض الشركة
الشرابية - القاهرة

٢٦٢.٥٠٦٢١.٠٠٩٢٢

٢٠٢٠/٠٥/٢٢

LG6650794

٢٠٢٠/٠٥/٢٢ ٢٦٢.٥٠٦٢١.٠٠٩٢٢

محامية حرة
أنش
مستشار
عبد القادر محمد عرب السيد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٥/٢٢

١



النقابة العامة للمحامين
مشروع الرعاية الصحية
للمحامين وأسرهم

شهادة

تشهد النقابة العامة للمحامين بأن الأستاذة / راقية محمد فرج حسين المحامية
المقيدة تحت رقم / 164364
غير مشتركة بمشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين ولم يتم الاستفادة منه لهذا
العام 2026.

وذلك

لتقديمها لأي جهة يرغب بها دون أدنى مسئولية على النقابة العامة للمحامين .

عضو المجلس

التوقيع /

التاريخ / 2026/2/7





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : رانيا محمد فرج حسين

Sex:

3- Medical number:

Female

83221729

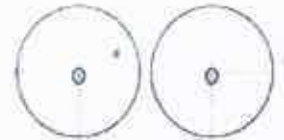
Old Med :

Old Med:

2429-2024

2-ID number: 26205062100922

Patient Age: 63 Y



Family history

Family history
-ve

Phone

Phone

01017979920

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
Post-Suct

Marital status

Marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2025-04-27

Co morbidity

Co morbidity
dm

Menopausal
status

Menopausal status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

It breast UOQ dysymmetry distortion with LIQ calcification with distortion
2--4 oclock with irregular multiple mass 1.2 x 1.8 + LN

Mets Workup :

prominent mediastinal LNs

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

Ki67

IDC

8/8

8/8

0

20

BX COMMENT

ER COMMENT

PR COMMENT

Her 2 Neu COMMENT

SISH COMMENT

T

N

M

4B

3

In

multicentric

Sonomammography

PATIENT HISTORY

received neoadj chth-->clinically responding
patient underwent It MRM ; YPT3, YPN2

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for AI , PORTH

zometa/ 6 month

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

Patient Name : **الاستاذة / رانيا محمد فرج حسين**
 Patient No. : **26205062100922**
 Path No. : **1190/25**
 Sex : **Female**
 Age : **62 Y**
 Referring Doc :

Request No. : **13004512**
 Request Date : **06/04/2025**
 Verification Date : **17/04/2025**
 Financial Category : **التأمين الصحي - مصرية**
 Department : **Out Patient**
 Registered by : **Mrs. Mayada Haggag**

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer post NACT.

Nature of the specimen: Left breast & Left axilla (MRM)(Post NACT)

Gross Examination:

• Procedure: Left MRM

measured 20x19x6 cm with covering skin ellipse measured 19x9cm

• Tumor extent : A grayish white tumour bed site

• Size: 8 x7 x3.5 cm . there was another focus (retroareolar) measured 0.5x0.5 cm . 1 cm below the nipple.

• Distance from margins: 2 cm away from deep margin, 0.5 cm from skin

• Axilla : Fibrofatty tissue piece measured 6x5x2 cm entangling 7 nodules up to 1.5x1 cm

• Microscopic examination:

• Histological type: Multifocal Invasive duct carcinoma , Actual tumour size 8x7 cm ,
 Cellularity 20%)

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Ductal carcinoma in situ: No

• Lymphovascular emboli: Positive

• Skin involvement: Free nipple and areola

• Lymph node involvement: Positive L.Ns (6/7)

• Resection Margins: Free margins

• Histologic response to therapy: Pathologic partial response

• Additional pathological findings : Positive calcification& old fibroadenoma

Diagnosis:

Left MRM (post NACT) :

Multifocal Invasive duct carcinoma grade II (Actual tumour size 8x7cm)

• Free margins

• Free nipple and areola

Verified by

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 15/05/2025 11:53:57

Page 1 of 2

Printing By : mervat.haggag

Patient Name :	الأنثى / رانيا محمد فرج حسين	Request No. :	13004512
Patient No. :	26205062100922	Request Date :	06/04/2025
Path No. :	1190/25	Verification Date :	17/04/2025
Sex :	Female	Financial Category :	مستشفى - ميسرة
Age :	62 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc :		Registered by :	Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

- Positive L.Ns (6/7)
- Pathologic partial response
- Stage : ypT3 , ypN2
- RCB : 4.158 , RCB class III

Comment : There was retroareolar malignant lesion as another focus

Signature

Dr. Rana Fathy

Dr. Heba Hassan

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date: 15/05/2025 11:53:57

Page 2 of 2

Printing By : marwa.hassan



س. شوقي

Patient Name	الإسلام / رالية محمد ارج حسين	Request No.	: 13009248
Patient No.	: 26205062100922	Request Date	: 29/06/2024
Path No.	: 2149/24	Verification Date	: 09/07/2024
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - مبداء
Age	: 62 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast swelling.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 29/6/2024.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1.2 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma with micropapillary features.
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: Negative.
- * Perineural invasion: Negative.
- * Angiolymphatic invasion: Negative.

Diagnosis:

Left breast swelling, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, with micropapillary features.
For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature

Prof. Dr. Lubna Omar.

Dr. Menna Nabil.

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 29/07/2024 08:35:13

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



براق رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - معمل الباثولوجيا - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Miss El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأمل / رانيا محمد أراج حسن
Patient No. : 26205062100922
Path No. : 2149/24
Sex : Female
Age : 62 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13009248
Request Date : 29/06/2024
Verification Date : 27/07/2024
Financial Category : Out Patient
Department :
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 29/6/2024.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

- IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 20% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II, with micropapillary features.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 20 % of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, > 1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 29/07/2024 08:35:17

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yusuf



الهيئة العامة للغذاء والدواء - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 287 - Nile Corniche - Near El Qalaa - Cairo, Egypt

Patient Name: الأمل / راقية محمد فرج حسين
Patient No.: 26205062100922
Path No.: 2149/24
Sex: Female
Age: 62 Y
Referring Doc.:

Request No.: 13009243
Request Date: 29/06/2024
Verification Date: 27/07/2024
Financial Category: Out Patient
Department:

Registered by: manwa mohamed

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Gamal Abd-El-Aty.
Dr. Sagda El-kady.

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 29/07/2024 08:35:17

Page 2 of 2

Printed By : manwa mohamed



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche- Misr El Qadima- Cairo, Egypt

Patient Name: Rakiah Mohamed Farag Hussein	Date: 31/07/2024
Exam: C.T CHEST	Age: 62 Year(s)
Medical ID: 2429/2024	Pat. ID: 49170

NON-CONTRAST MULTI-PLANE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALS:

1. Chest:

- Diffuse heterogenous left breast parenchyma with retroareolar symmetrical density and mild overlying skin thickening.
- Multiple pathologically enlarged left axillary (level 1, 2 and 3) as well as left supraclavicular lymph nodes, the largest measures about 1.8x 3 cm.
- Left retro-areolar partially calcified soft tissue nodule measuring about 1.9 cm.
- Few subcentimetric left internal mammary lymph nodes, the largest measures about 0.6 cm.
- Multiple prominent superior mediastinal, para-tracheal, prevascular and subcarinal lymph nodes, the largest is prevascular measuring about 1.1x 1.6 cm.
- Multiple bilateral subcentimetric pulmonary nodules, the largest is seen at posterior segment of right upper lung lobe measuring about 0.5 cm.
- No pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions (on non-contrast basis) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal non contrast appearance of the pancreas and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- L2 tiny sclerotic focus.
- No sizable lytic bone lesions.

OPINION:

- Diffuse heterogenous left breast parenchyma with mild overlying skin thickening.
- Multiple pathologically enlarged left axillary and left supraclavicular lymph nodes.
- Multiple prominent mediastinal lymph nodes.
- Multiple bilateral subcentimetric pulmonary nodules, for follow up.

Dr. Ghada H. Khalifa, MSc

Signature Dr. Mohamed Mohsen

10/08/2024 01:04



Patient Name: Rakiah Mohamed Farag Hussein	Date : 27/02/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 63 Year(s)
Medical ID: 2429/2024	Pat. ID: 49170

Comblned bilateral breast mammography and complementary
ultrasound

Indication:

left breast palpable lump.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows lower central speculated mass with related regional microcalcifications over an area measured 6x3cm
- Left breast:
- Spiculated mass lesion is seen at 6 o'clock measured 16x11 mm with related dilated retroareolar ducts reaching nipple
- The previously reported 2- to 4 o'clock altered parenchyma is not currently appreciated
- Single left axillary LN showing focal cortical thickening reaching 4mm
- Free left supra calvilaur and infraclavicular region
- Still noted left retroareolar Involutd fibroadenoma measured 2.5x1.8cm
- right breast,
- No right breast lesions
- Nonspecific right axillary LN.

Opnlon:

- Partial radiological response regarding the left breast multicentric malignant process with residual Left breast 6 o'clock malignant looking mass lesion (BIRADS 6) for histopathological correlation.
- Pathological single left axillary LNs.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. basma mohmaod

27/02/2025 3:42 PM